



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN TERAPI GIZI

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 571.87/I-PDM/DIR/VI/2025

Tentang
Pedoman Terapi Gizi

Disusun oleh :
Kepala Instalasi Gizi



(Ericha Risdawati, AMd.Gz)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M. Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Terapi Gizi dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Terapi Gizi ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Terapi Gizi ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 13 November 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

TIM PENYUSUN
PEDOMAN TERAPI GIZI

Pengarah & Editor : Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CCHt., CI., CHAE., CHQP

Penyusun:

1. Veni Lestari Puri Purnami, AMd.Gz
2. Ericha Risdawati, AMd.Gz
3. Suci Nur Pratiwi, S.Gz
4. Chandrawati Mustikasari, S.Tr.Gz
5. Alfira Chaerunisa, S.Tr.Gz
6. Nafisah Ulfa Hasanah, S.Gz
7. dr. Dicky Faturrachman, Sp. A
8. dr. Ari Putriani, Sp. PK
9. dr. M. Kuntadi Syamsul Hidayat, Sp. OT
10. dr. Heriyatmo, Sp. PD
11. dr. Antonius Setiadi, Sp. B
12. dr. Aida Musyarrofah, Sp. OG
13. dr. Nurhadhi Sutanto, Sp. M
14. dr. Miryanti Cahyaningtias, Sp. JP
15. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An
16. dr. Arianto Prabowo, Sp. OT
17. dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ
18. dr. Pradana Nurhadi, Sp. U
19. dr. Dwi Nurwulan Pravitasari, Sp. KK
20. dr. Eko Nugroho, Sp. KFR
21. dr. Titok Hariyanto, Sp. M
22. dr. Ira Setya Waty, Sp. JP
23. dr. Humaira Rahma, Sp. OG
24. dr. Iwan Donosepoetro, SP. B FINACS
25. dr. Catur Elvi Purnamawati, Sp. P
26. dr. Sigit Wahyu Jatmiko, Sp. BP-RE
27. dr. Dewi Maharani, Sp. S

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR..... iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA viii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 1

 1.3 Ruang Lingkup 2

 1.4 Pengertian 2

BAB II TATA LAKSANA PELAYANAN TERAPI GIZI 3

 2.1 Proses Terapi Gizi Baku 3

BAB III PENGORGANISASIAN TERAPI GIZI 8

 3.1 Sub Komite Terapi Gizi..... 8

 3.2 Tim Terapi Gizi 8

 3.3 Peranan Tim Terapi Gizi 9

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 11

BAB V PENUTUP 12

DAFTAR TABEL

TABEL 1 RESIKO NUTRISIONAL 3

TABEL 2 DIAGNOSA GIZI YANG SERING MUNCUL 4

TABEL 3 PERANAN ANGGOTA TIM TERAPI GIZI..... 9

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 ALUR PELAYANAN TERAPI GIZI 6

GAMBAR 2 PENGORGANISASIAN TIM TERAPI GIZI RS 8

GAMBAR 3 ALOGARITMA TERAPI GIZI 13

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 571.87/I-PDM/DIR/VI/2025**

TENTANG

PEDOMAN TERAPI GIZI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamanatkan upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, untuk itu Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar pelayanan gizi dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan dengan Peraturan Direktur tentang Pedoman Terapi Gizi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Keselamatan Pasien;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak
12. Kepdrijen Nomor HK 0107/MENKES/1596/2024 tentang Instrumen Survey Akreditasi Rumah Sakit.
13. Kepdrijen Nomor HK.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman survey Akreditasi Rumah Sakit
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi;
- Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPM-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN TERAPI GIZI**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rumah sakit menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien.
- (2) Proses pemesanan makanan pasien sesuai dengan status gizi dan kebutuhan pasien serta dicatat di rekam medis.
- (3) Makanan disiapkan dan disimpan dengan mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan.
- (4) Distribusi makanan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Jika keluarga membawa makanan bagi pasien, mereka diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan risiko kontaminasi serta pembusukan sesuai dengan regulasi.
- (6) Makanan yang dibawa keluarga pasien atau orang lain disimpan didalam nakas secara benar untuk mencegah kontaminasi.

Pasal 2

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi untuk terapi gizi terintegrasi.
- (2) Pemberian terapi gizi terintegrasi pada pasien risiko nutrisi (Malnutrisi/Obesitas, pasien pasca bedah, bumil dengan HEG, dan pasien ICU).
- (3) Asuhan gizi terintegrasi mencakup rencana, pemberian, dan monitor terapi gizi.
- (4) Evaluasi dan monitoring terapi gizi dicatat di rekam medis pasien.

Pasal 3

Petugas gizi yang bertugas harus memiliki Surat Izin sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Peralatan dilakukan pemeliharaan dengan baik.
- (2) Pencucian peralatan makanan dilakukan secara sentral dan dilakukan oleh tenaga yang terlatih.
- (3) Pelayanan gizi harus senantiasa berorientasi pada kecukupan gizi pasien, serta mutu dan keselamatan pasien.
- (4) Pemeriksaan rectal swab petugas penjamah makanan dan pemeriksaan swab alat makan dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Pasal 5

- (1) Bentuk sediaan dan kandungan gizi harus sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan atas permintaan dokter.
- (2) Penyediaan bahan makanan, pengolahan bahan makanan dan pendistribusian makanan harus memperhatikan kualitas dan persyaratan kesehatan dan harus dibawah pengawasan ahli gizi (D3/D4/S1 Gizi).

- (3) Pola penyediaan makan untuk pasien terdiri dari 3 kali makan dan 1 kali snack dalam waktu tertentu, dan disesuaikan dengan kondisi pasien.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan estimasi pemesanan makanan diluar jam estimasi yang di jadwalkan, maka tidak dilayani.
- (2) Pengambilan peralatan makan diambil satu jam setelah makanan terbagi.
- (3) Penentuan porsi makanan pasien ditentukan dengan standar rumah tangga.

Pasal 7

- (1) Skrining gizi dilakukan pada semua pasien rawat inap.
- (2) Skrining gizi dilakukan dalam 1x24 jam setelah pasien masuk rumah sakit oleh ahli gizi.
- (3) Setelah pasien dilakukan skrining, pasien yang mengalami malnutrisi dilakukan asuhan gizi lebih lanjut oleh ahli gizi. Untuk pasien dengan status gizi normal dan tidak ada kebutuhan diet khusus evaluasi dilakukan setelah 3 hari.

Pasal 8

- (1) Asuhan gizi dilakukan pada pasien yang mengalami malnutrisi yang didapatkan dari hasil skrining gizi.
- (2) Asuhan gizi dilakukan juga terhadap pasien yang obesitas, pasien pasca bedah, bumil dengan HEG, dan pasien ICU.
- (3) Asuhan gizi dilakukan mulai asesmen pasien meliputi pengkajian data antropometri, fisik klinis kemudian dilanjutkan dengan menegakkan diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelayanan Konsultasi Gizi dilaksanakan oleh petugas gizi.
- (2) Petugas gizi harus melakukan identifikasi, komunikasi dan penjelasan mengenai makanan yang diberikan kepada pasien.
- (3) Pemberian komunikasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga dilakukan dengan cara yang seragam.

Pasal 10

- (1) Kriteria pemilihan makanan di instalasi gizi adalah Halal.
- (2) Pasien berhak menentukan makanan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, sesuai dengan regulasi RS Prima Husada.

Pasal 11

- (1) Pasien tidak diperkenankan membawa makanan dari luar rumah sakit dan harus mengikuti aturan diet dari ahli gizi rumah sakit Prima Husada
- (2) Skrining barang bawaan pasien saat jam berkunjung dilakukan oleh petugas security dan petugas ruang perawatan.
- (3) Jika keluarga membawa makanan bagi pasien, mereka diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan risiko kontaminasi serta pembusukan sesuai dengan regulasi.

Pasal 12

Seluruh pelayanan gizi berorientasi kepada kepuasan pasien.

Pasal 13

Petugas gizi tidak diperkenankan meminjamkan segala macam peralatan makan yang ada di pantry kepada pasien/keluarga pasiennya lainnya, karena untuk mengurangi infeksi tertular yang diakibatkan penyakit pasien.

Pasal 14

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 13 November 2025
PLT Direktur RS Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes

PEDOMAN TERAPI GIZI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Makanan dan nutrisi yang sesuai sangat penting bagi kesehatan pasien dan penyembuhannya. Pilihan makanan disesuaikan dengan usia, budaya, pilihan, rencana asuhan, diagnosis pasien termasuk juga antara lain diet khusus seperti rendah kolesterol dan diet diabetes melitus. Berdasar atas asesmen kebutuhan dan rencana asuhan maka DPJP atau PPA lain yang kompeten memesan makanan dan nutrisi lainnya untuk pasien.

Pasien berhak menentukan makanan sesuai dengan nilai yang dianut. Bila memungkinkan pasien ditawarkan pilihan makanan yang konsisten dengan status gizi.

Jika keluarga pasien atau ada orang lain mau membawa makanan untuk pasien maka kepada mereka diberikan edukasi tentang makanan yang merupakan kontraindikasi terhadap rencana, kebersihan (*hygiene*) makanan dan kebutuhan asuhan pasien termasuk informasi terkait interaksi antara obat dan makanan.

Makanan yang dibawa oleh keluarga atau orang lain disimpan dengan benar untuk mencegah kontaminasi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tercapainya pelayanan gizi yang optimal sebagai bagian terapi dalam pelayanan holistic kepada pasien sehingga dapat mengurangi morbiditas, mortalitas dan lama rawat yang Panjang
2. Tercapainya efisiensi dan keefektifan dalam terapi gizi, baik dari segi klinis, fungsional, kepuasan pasien dan biaya.
 - a. Segi klinis : Pengukuran anatomis dan faal seperti berat badan, imbang nitrogen, serum albumin dan kadar kolesterol, termasuk juga akibat perawatan berupa insiden infeksi, rehospitalisasi dan pemakaian obat.
 - b. Segi Fungsional : Pengukuran kemampuan fisik, fungsi psikososial, dan berkurangnya keluhan nyeri atau ketidak-nyamanan.

- c. Segi kepuasan pasien : Mengukur pelayanan kesehatan untuk memenuhi harapan pasien dan dampak pada kualitas hidup.
- d. Segi biaya : Penurunan beban biaya untuk pasien atau penanggung biaya (menurunnya lama rawat dan frekuensi visite dokter).

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup gizi meliputi :

1. Pelayanan gizi rawat jalan
2. Pelayanan gizi rawat inap
3. Penyelenggaraan makanan

1.4 PENGERTIAN

1. Terapi Gizi adalah pelayanan gizi klinik dan asuhan gizi yang merupakan bagian dari pelayanan medis untuk penyembuhan pasien yang diselenggarakan secara terpadu dengan upaya pelayanan gizi promotive, preventif dan rehabilitative.
2. Sub Komite Terapi Gizi merupakan unit kerja yang berada dibawah komite medis RS yang beranggotakan Staf medik fungsional terkait sub komite terapi gizi bertugas memberi masukan kepada pimpinan rumah sakit dalam menertibkan kebijakan dan strategi untuk peningkatan mutu pelayanan gizi klinik dan asuhan gizi.
3. Tim Terapi Gizi (TTG) merupakan sekelompok tenaga kesehatan di Rumah Sakit yang berkaitan penyelenggaraan terapi gizi meliputi dokter spesialis, dokter, dietisien, perawat ruangan serta ahli farmasi dan mempunyai komitmen untuk menyediakan waktu untuk pelayanan gizi klinik dalam TTG. Tim terapi Gizi dibentuk oleh pimpinan Rumah Sakit dan diketuai oleh dokter yang mempunyai kompetensi dalam bidang gizi klinik serta menyediakan waktu penuh untuk pelayanan gizi klinik

BAB II

TATA LAKSANA PELAYANAN TERAPI GIZI

2.1 PROSES TERAPI GIZI BAKU

Tahapan langkah proses terapi gizi dari skrining/penapisan, kajian, diagnosis medik dan diagnosis gizi (penentuan masalah gizi) formulasi terapi (intervensi gizi), pelaksanaan terapi, pemantauan dan evaluasi terapi, penyusunan rencana ulang terapi atau penghentian terapi. Rangkaian langkah tersebut bertujuan untuk memberi dampak terapi yang optimal bagi pasien dan mempunyai keefektifan biaya.

Langkah - langkah :

1. Skrining/Penapisan Gizi

Skrining gizi bertujuan mengidentifikasi status gizi pasien yang masuk dalam kategori malnutrisi atau resiko malnutrisi, sehingga membutuhkan kajian gizi yang lebih mendalam. Metode skrining dan kategori malnutrisi ditetapkan oleh Tim.

Tabel 1. Pasien dengan risiko nutrisi pada dewasa adalah :

Kategori		IMT
Kurus	Kekurangan BB tingkat berat	<17,0
	Kekurangan BB tingkat ringan	17,0-18,0
Normal		18,5-25
Gemuk	Kelebihan BB tingkat ringan	25,0-27,0
	Kelebihan BB tingkat berat	>27,0

Tabel 2. Pasien dengan risiko nutrisi pada anak adalah :

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Berat Badan Menurut Umur (BB/U) anak usia 0-6 Bulan	Berat badan sangat kurang	<- 3 SD
	Berat Badan Kurang	-3 SD sd <-2 SD
	Berat Badan Normal	-2 SD sd + 1 SD
	Risiko Berat Badan Lebih	>+1 SD
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0-60 Bulan	Sangat Pendek (severely stunted)	<- 3 SD
	Pendek (stunted)	-3 SD sd <-2 SD
	Normal	-2 SD sd + 1 SD
	Tinggi	>+1 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0-60 bulan	Gizi Buruk	<- 3 SD
	Gizi Kurang	-3 SD sd <-2 SD
	Gizi Baik	-2 SD sd + 1 SD
	Berisiko gizi lebih	>+1 SD sd +2 SD
	Gizi Lebih	>+2 SD sd + 3SD
	Obesitas	>+3 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)	Gizi Buruk	<- 3 SD
	Gizi Kurang	-3 SD sd <-2 SD
	Gizi Baik	-2 SD sd + 1 SD
	Gizi lebih	>+1 SD sd +2 SD

anak usia 0-60 bulan	Obesitas	>+2 SD sd + 3SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 5-18 tahun	Gizi Buruk	<- 3 SD
	Gizi Kurang	-3 SD sd <-2 SD
	Gizi Baik	-2 SD sd + 1 SD
	Gizi lebih	>+1 SD sd +2 SD
	Obesitas	>+2 SD sd + 3SD

Skrining sebaiknya bersifat sederhana dan cepat. Data skrining umumnya meliputi umur, gender, diagnose medik, berat badan, tinggi badan, perubahan BB dan diet yang sedang dijalankan. Pelaksanaan skrining dapat dilakukan oleh anggota tim yang berwenang sesuai kompetensinya.

2. Kajian Gizi

Kajian gizi dilakukan pada pasien yang masuk dalam kategori malnutrisi maupun resiko malnutrisi. Kajian gizi merupakan proses sistematis dalam pengambilan, verifikasi dan interpretasi data untuk menetapkan masalah gizi yang berkaitan dengan penyakitnya, status gizi dan perubahan metabolismenya. Kajian ini merupakan dasar formulasi terapi gizi.

Komponen kajian gizi :

- a. Riwayat makan, medis, obat-obatan dll yang berkaitan dengan masalah gizi.
- b. Pemeriksaan fisik termasuk pengukuran antropometri
- c. Pemeriksaan Laboratorium dan penunjang lainnya.

3. Diagnosis Medis Dan Diagnosa Gizi (Penentuan Masalah Gizi)

Diagnosa gizi terdiri dari 3 Domain, yaitu :

- a. Domain Intake (NI), merupakan kelompok permasalahan gizi yang berhubungan dengan intake/asupan gizi pasien
- b. Domain Klinis (NC), merupakan kelompok permasalahan gizi yang berhubungan dengan keadaan fisik-klinis, kondisi medis dan hasil pemeriksaan labortorium
- c. Domain Perilaku (NB), merupakan kelompok permasalahan gizi yang berhubungan dengan kebiasaan hidup, perilaku, kepercayaan, lingkungan, dan pengetahuan gizi pasien

Tabel 2. Diagnosa Gizi yang sering muncul :

KODE	PROBLEM	ETIOLOGI	SIGN/SYNDROM	TUJUAN DIET
NC 3.1	BB kurang	-asupan makan -kebutuhan meningkat -pola makan yang salah -kurangnya pengetahuan tentang makanan seimbang	IMT dibawah 17,5 dan pasien tampak kurus	Meningkatkan Status gizi
NC 3.3	BB Lebih	-aktifitas fisik yang kurang	IMT lebih dari 26	Menurunkan BB

		-peningkatan stress psikologis		
NI 1.1	Peningkatan kebutuhan energi	Adanya infeksi	Lekosit tinggi (tuliskan angkanya)	Memberikan makanan yang tinggi energy dan protein untuk meningkatkan daya tahan tubuh
NC 2.2	Perubahan nilai lab. Terkait kadar glukosa darah	Gangguan fungsi endokrin	GDA tinggi, HBA1C tinggi, BSN tinggi	Menurunkan kadar gula darah mencapai normal
N1 51.2	Kelebihan intake lemak	Pola makan salah	Profil lemak tinggi (LDL, TG, Chol)	Menurunkan asupan lemak
NC 2.2	Perubahan nilai lab. Terkait BUN/SC	Gangguan fungsi ginjal	BUN/SC tinggi (tuliskan angka)	Memberikan makanan rendah protein agar tidak memperberat kerja ginjal
NC 2.2	Perubahan nilai lab. Terkait HB	-Pendarahan -Gangguan fungsi organ -Kurang asupan Fe	HB rendah (tuliskan angka)	Memberikan makanan tinggi Fe
NI 1.1	Peningkatan keb. energi	Adanya infeksi di usus	Hasil widal positif	Memberikan makanan yang tinggi energi dan protein
NI 5.4	Penurunan kebutuhan Na	Hipertensi	Tensi tinggi (tuliskan angka)	Menurunkan TD mencapai normal
NI 3.1	Peningkatan keb. energi	Adanya infeksi	Tingginya suhu tubuh (diatas normal >37C)	Memberikan cairan tinggi untuk mengimbangi cairan yang hilang
NI 3.1	Kekurangan intake cairan	Diare/muntah	Frekuensi feces/muntah lebih dari 3x sehari	Memberikan cairan tinggi untuk mengimbangi cairan yang hilang
NB 1.5	Pola makan salah	Kondisi lingkungan	Makan tidak teratur	Memberikan edukasi

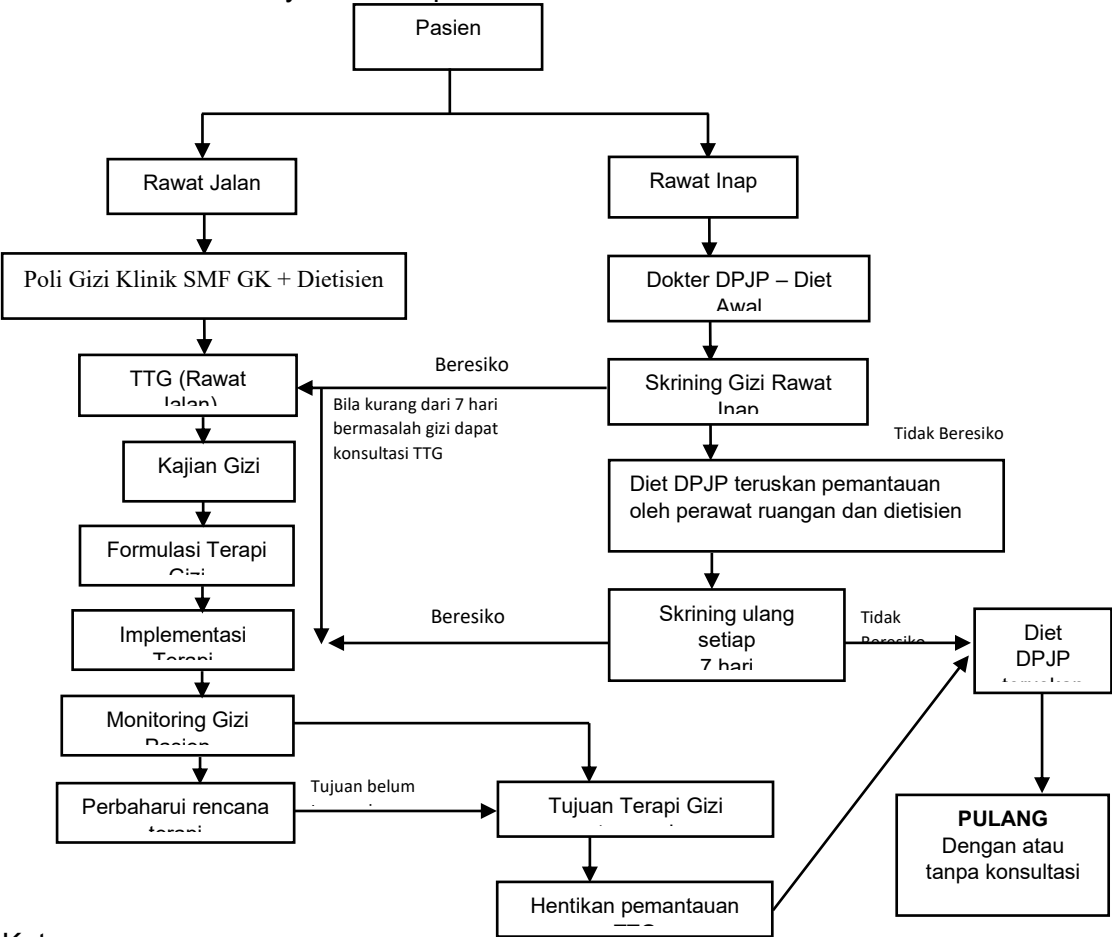
		pasien yang tidak mendukung		tentang manfaat makan teratur
		Kurangnya pengetahuan tentang manfaat sayur dan menu seimbang	Tidak suka makan sayur dan buah	Memberikan edukasi tentang manfaat gizi seimbang
NB 1.2	Kebiasaan makan yang salah	Kurangnya pengetahuan tentang makanan	Suka makanan yang digoreng,bersantan,jerohan	Memberi informasi tentang pola makan yang sehat dan seimbang

4. Formulasi Rencana Terapi Gizi

- a. Penetapan waktu dimulainya pemberian terapi gizi
- b. Penetapan kebutuhan energi. Perhitungan bergantung pada BB, umur, gender, aktifitas fisik, *Specific dynamic action (SDA)* dan perubahan fisiologis dan metabolisme tubuh.
- c. Penetapan komposisi zat gizi pembentuk energi. Komposisinya bergantung pada diagnosis penyakit, perubahan metabolisme dan fungsi organ. Misalnya, KH sederhana untuk penderita DM harus rendah dan komposisi lemak untuk penderita gagal paru harus tinggi.
- d. Penetapan kebutuhan vitamin, mineral, elektrolit dan cairan. Kebutuhan vitamin dan mineral umumnya sesuai dengan diagnosis penyakit, perubahan metabolisme dan fungsi organ.
- e. Penetapan rute pemberian(oral. Enteral, parenteral) dan frekuensi pemberian makanan perhari.
- f. Penetapan bentuk dan kepekatan makanan bergantung pada kondisi saluran cerna dan cara pemberian.

Penetapan cara, bentuk dan kepekatan dapat dilihat pada lampiran alogaritma pemberian terapi gizi.

Gambar 1.1 Alur Pelayanan Terapi Gizi



Keterangan :

Pelayanan GK (Gizi Klinik) pasien rawat jalan dilaksanakan oleh SMF GK yang dibantu oleh dietisien. Pada pasien rawat inap, setelah pemeriksaan klinis, diagnosis, dan terapi termasuk diet awal oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien/DPJP (dokter yang bertanggung jawab dalam penatalaksanaan pasien sesuai bidang spesialisnya). Perawat ruangan melakukan skrining gizi. Bagi pasien bermasalah atau beresiko malnutrisi, langsung di kirim ke TTG untuk dilakukan pengkajian gizi, formulasi terapi gizi. Dan selanjutnya implementasi terapi gizi yang dilanjutkan monitoring/pemantauan serta evaluasi terapi gizi. Bila tujuan terapi gizi tercapai, TTG memutuskan penghentian pemantauan atau pemantauan selanjutnya diteruskan oleh DPJP. Dan bila tujuan belum tercapai dilakukan pembaharuan rencana terapi gizi.

5. Implementasi Terapi Gizi

Pelaksanaan implementasi gizi meliputi beberapa aspek yaitu pemberian makanan sesuai dengan rancangan diet serta pemberian konseling dan edukasi gizi sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan rumah sakit. Kegiatan ini dilakukan oleh tim sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Hasil kegiatan ini berupa pasien mendapat pelayanan gizi secara holistic.

6. Pemantauan Dan Evaluasi Terapi Gizi

Pemantauan dan evaluasi terapi gizi bertujuan untuk menilai proses dan keberhasilan implementasi terapi gizi serta rencana tindak lanjut terapi. Pemantauan dan evaluasi meliputi penetapan jadwal pelaksanaan dengan ruang lingkup antara lain:

- a. Dampak pemberian makanan terhadap status gizi, toleransi saluran cerna dan status hemodinamik serta kondisi metabolic pasien

-
- b. Faktor - faktor yang mempengaruhi asupan gizi seperti : kondisi nafsu makan, jumlah makanan yang tidak dimakan (sisa), makanan dari luar rumah sakit yang dimakan, reaksi saluran cerna terhadap makanan dan lain - lain.

7. Konseling

Tujuan konseling adalah memberikan edukasi untuk memahami dan mampu merubah perilaku diet sesuai dengan yang di anjurkan. Konseling diberikan kepada pasien dan atau keluarganya yang membutuhkan untuk mendapatkan penjelasan tentang diet yang harus dilaksanakan oleh pasien sesuai dengan penyakit dan kondisinya.

Konseling dilakukan oleh anggota tim sesuai dengan kompetensinya

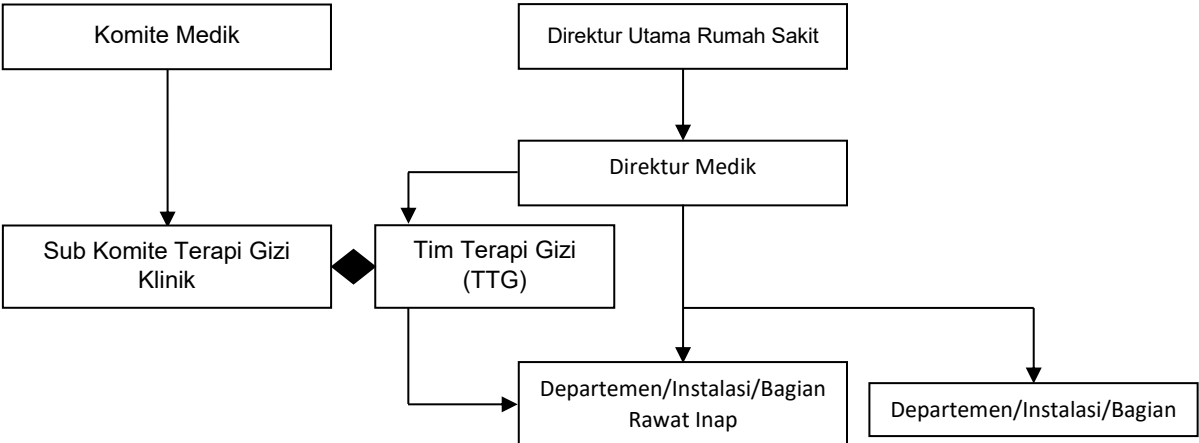
BAB III

PENGORGANISASIAN TERAPI GIZI

Organisasi TTG dibentuk oleh pimpinan Rumah Sakit dan diketuai oleh dokter yang mempunyai kompetensi dalam bidang gizi klinik serta menyediakan waktu penuh untuk pelayanan gizi klinik. Anggota TTG terdiri dari tenaga kesehatan di Rumah Sakit yang berkaitan penyelenggaraan terapi gizi meliputi dokter spesialis gizi klinik, dokter spesialis, dokter, dietisien, perawat ruangan serta ahli farmasi.

Agar TTG dapat berfungsi secara optimal maka dibuat pengorganisasian dan jalur koordinasi pelayanan gizi klinik sebagai berikut :

Gambar 2.1 Pengorganisasian Tim Terapi Gizi Rumah Sakit



*Disesuaikan Kebijakan dan Struktur RS

3.1 SUB KOMITE TERAPI GIZI

Sub Komite terapi gizi adalah unit kerja dibawah komite medik Rumah sakit yang beranggotakan staf medik fungsional terkait bertugas memberi masukan kepada pimpinan rumah sakit dalam menerbitkan kebijakan dan strategi untuk peningkatan mutu pelayanan gizi klinik dan asuhan gizi.

Peran dan Fungsi

1. Pendidikan dan pelatihan
Menyusun dan mengembangkan modul pelatihan/Pendidikan interdisipliner sesuai dengan yang telah ditetapkan mengenai terapi gizi bagi dokter, dietisien, perawat dan farmasi di lingkungan Rumah Sakit.
2. Penelitian dan penapisan teknologi
 - a. Bersama dengan unit terkait di rumah sakit melakukan penelitian terhadap penerapan terapi gizi atau uji klinis produk baru untuk dukungan gizi dan metabolic.
 - b. Menyusun parameter kajian metabolic dan status gizi.

3.2 TIM TERAPI GIZI

Susunan personil Tim Terapi Gizi, beranggotakan :

1. Dokter spesialis gizi klinik
2. Dokter spesialis yang berkompetensi gizi klinik
3. Dokter yang berkompetensi gizi klinik

- Dietisien
- Perawat
- Ahli Farmasi

Tim Terapi Gizi dipimpin oleh Dokter spesialis gizi klinik. Kompetensi dicapai dengan mengikuti kursus / pelatihan terapi gizi yang diakui oleh Depkes dan IDI.

- Dietisien
Diutamakan yang mempunyai kompetensi pelayanan dietetic Rumah Sakit atau dietisien yang telah berpengalaman kerja di rumah sakit minimal 2 tahun.
- Perawat yang berpengalaman dan berkompetensi di bidang gizi klinik. Diutamakan bagi yang sudah mengikuti kursus yang berhubungan dengan pelayanan gizi klinik.
- Ahli Farmasi
Apoteker yang diutamakan telah mengikuti kursus / pelatihan farmasi klinik khususnya mixing and compounding nutrisi parenteral yang diakui oleh Depkes dan organisasi profesi terkait.

Peran dan Fungsi

- Pelayanan pada pasien rawat inap
Kajian status gizi dan metabolic dan pengelolaan pasien yang membutuhkan gizi oral, enteral maupun parenteral, serta pengawasannya melalui visite tim.
- Pencatatan dan Pelaporan
Dilakukan oleh semua anggota tim sesuai dengan fungsi masing-masing anggota.
- Program Kemitraan
 - Menyusun program terapi terpadu Bersama dokter-dokter yang merawat atau dokter penanggung jawab pasien (DPJP).
 - Menyusun pertemuan berkala.
 - Menyusun program kerjasama dalam bidang penelitian dan pendidikan bersama unit-unit terkait di dalam maupun diluar rumah sakit.

3.3 PERANAN ANGGOTA TIM TERAPI GIZI

No	Kegiatan	Dokter	Dietisien	Perawat	Farmasi
1.	Skrining Gizi			Perawat TTG atau perawat ruang rawat inap (sesuai kebijakan Rumah Sakit)	
2.	Anamnesis	a. Keluhan utama b. Riwayat penyakit c. Riwayat penyakit dahulu	a. Kebiasaan makan sebelum sakit dan saat sakit b. Analisis asupan gizi (<i>food recall</i> &	a. Identitas pasien b. Mengkaji keluhan pasien c. Konsumsi makanan dan	

No	Kegiatan	Dokter	Dietisien	Perawat	Farmasi
		d. Riwayat penyakit dalam keluarga e. Riwayat masalah gizi f. Riwayat kelahiran	<i>food frequency</i>) c. sebelum sakit d. selama sakit	cairan beberapa hari terakhir d. Mengkaji perkembangan keluhan pasien e. Keluhan yang berkaitan dengan makanan (alergi dll)	
3.	Pemeriksaan Fisik	a. Analisis hasil pemeriksaan Antropometri b. Pemeriksaan tingkat kesadaran dan tanda kegawat-daruratan c. Pemeriksaan status generalis inspeksi, perkusis, palpasi dan auskultasi	Pemeriksaan Antropometri awal	a. Penimbangan BB dan ukur TB/PB b. Evaluasi tanda vital (TD, Suhu, Nadi, dan pernafasan) dan kegawatdaruratan	
4.	Tindakan	a. Menetapkan status gizi pasien b. Menentukan terapi gizi sesuai diagnosis c. Preskripsi terapi gizi (jenis, bentuk, jumlah frekuensi pemberian makanan)	a. Analisis asupan makanan selama perawatan b. Menyediakan makanan sesuai preskripsi dokter c. Analisis asupan makanan (<i>food record</i> jumlah dan komposisi asupan)	Pemantauan: a. Tanda vital b. Status Gizi c. intake-output cairan d. Perkembangan penyakit dan keluhan pasien e. Tanda - tanda infeksi, perawatan infus dan Nasogastric tube f. Membuat surat control ulang	Mempersiapkan obat - obatan dan zat terkait, vitamin, mineral, elektrolit, dan nutrisi parenteral. Menentukan kompatibilitas zat gizi yang akan diberikan kepada pasien

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses manajemen, karena dengan evaluasi akan diperoleh umpan balik (*feedback*) terhadap program atau pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang direncanakan tersebut telah dicapai, maka diperlukan memonitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan sejalan dengan evaluasi, dengan tujuan agar kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik dari waktu maupun jenis kegiatannya. Dalam praktiknya, monitoring atau pemantau kadang diidentikan dengan evaluasi proses dari suatu program. Dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat, selain evaluasi juga dilakukan monitoring atau pemantauan program. Dalam kegiatan monitoring, dilakukan pencatatan atau pengamatan. namun tidak dilakukan penilaian sebagaimana yang dilakukan pada kegiatan evaluasi. Jika terjadi ketidaksesuaian antara kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan koreksi atau pembetulan, termasuk pembetulan terhadap penggunaan sumber daya (biaya, tenaga, dan sarana).

Pelaporan merupakan system atau metode yang dilakukan untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang ada terkait dengan pemberian terapi gizi di rumah sakit

Jenis laporan terdiri dari :

1. Laporan Harian

Laporan harian berupa pencatatan jumlah makanan diet pasien rawat inap, pencatatan data/register pasien rawat inap dan rawat jalan yang mendapatkan asuhan gizi berupa konsultasi gizi.

2. Laporan Bulanan

Laporan bulanan yang dibuat setiap bulannya dan diserahkan ke sekretariat.

Adapun hal-hal yang dilaporkan adalah:

- a. Laporan SDM Gizi yang meliputi :
 - 1) Kuantitas SDM
 - 2) Kualitas SDM
- b. Laporan fasilitas dan sarana Gizi yang meliputi :
 - 1) Kelengkapan alat dan fasilitas
 - 2) Kondisi alat dan fasilitas
- c. Laporan Produktivitas Gizi yang meliputi :
 - 1) Jumlah pemberian diet pasien
 - 2) Jumlah KIE rawat inap
 - 3) Jumlah KIE rawat jalan
- d. Laporan Kinerja Mutu
 - 1) Indikator mutu pelayanan
 - 2) Indikator keselamatan pasien

BAB V

PENUTUP

Terapi gizi merupakan bagian dari pelayanan medis yang memberi kontribusi penyembuhan pasien dan menurunkan angka malnutrisi rumah sakit, lama hari rawat dan biaya perawatan.

Manajemen rumah sakit wajib memberikan dukungan terhadap TTG dalam bentuk kebijakan dan operasional dengan membentuk Tim Terapi Gizi, meningkatkan profesionalisme tenaga dan penetapan biaya makan pasien dipisahkan dari biaya perawatan, sehingga biaya terapi gizi merupakan bagian dari biaya makan pasien.

Keberadaan Tim Terapi Gizi merupakan salah satu kriteria standar pelayanan rumah sakit dan dijadikan kriteria penilaian akreditasi, sehingga mutu pelayanan gizi rumah sakit dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 13 November 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

ALOGARITMA TERAPI GIZI

